



EVCF 2012

Connaissances fondamentales

Médecine générale

Cette annale contient

1 sujet · 20 questions

01 SUJET 1**VIGNETTE CLINIQUE**

Sujet : Partie 1 : HEMATOLOGIE Une femme de 34 ans se présente en consultation avec l'hémogramme suivant : Gr : 3,9 millions/m³ Hémoglobine : 8 g/dl VGM : 68 fl Hte : 27 % Plaquettes : 510000/m³ GB 300 /m³ : 62% PE : 2 % PB : 0 Lymphocytes : 28 % Monocytes : 8 %

1 QUESTION
Décrivez les anomalies de l'hémogramme.

2 QUESTION
Concernant la lignée érythrocytaire, citez les 2 mécanismes physiopathologiques principaux envisageables.

3 QUESTION
Quel est l'examen biologique courant le plus adapté pour faire un premier tri entre ces mécanismes ?

Réponses proposées :
(Une seule réponse)

4 QUESTION
Quel est le résultat attendu de cet examen pour chacun des 2 mécanismes ?

Réponses proposées :
Tournez S.V.P. (Partie 2 : CARDIO-VASCULAIRE Vous êtes appelé au domicile de M. G., 65 ans, 1m78, 95 kg, hypertendu traité, tabagique chronique, pour une violente douleur de la jambe gauche survenue 4 heures auparavant et persistant depuis. A votre arrivée vous notez une jambe gauche blanche et froide.

1 QUESTION
Quelle est votre principale hypothèse diagnostique ?

Réponses proposées :
(Sans détailler)

2 QUESTION
Tenant compte de votre hypothèse, quels sont les 3 signes cliniques que vous devez rechercher à ce stade sur ce membre inférieur gauche ?

3

QUESTION

Ces 3 signes vont vous apporter des renseignements importants pour votre prise en charge thérapeutique. Quels sont ces 3 renseignements ?

4

QUESTION

Quels sont les 2 grands mécanismes physiopathologiques que vous devez évoquer de principe pour expliquer la symptomatologie aiguë présentée par M.G. (sans détailler) Tournez S.V.P. (Partie 3 : POLYPATHOLOGIE DU SUJET AGE Patiente de 85 ans adressée aux urgences après une chute (retrouvée sur le sol par sa voisine) et confuse. ATCD : HTA Diabète de type II Ostéoporose AC/FA Conditions de vie : veuve depuis 3 mois, vit seule, autonome auparavant. Traitement : Warfarine (Coumadine) Bêta bloquant : cardensiel 2,5 l cp /jour Diamicron 60 LM 1 cp 1 cp le matin Amlor (Amlodipine) 5 l cp 1/jour Contramal LP (Tramadol) 2 cp x jour Lexomil cp le soir depuis quelques jours Bilan biologique : Glycémie 0,70 g/l Na : 147 mMol/l K : 4 mMol/l Créatinine : 120 mol/l Urée : 15 mMol/l INR : 2

10

QUESTION

Question 1 : Citez 5 mécanismes favorisant ou précipitant la chute chez cette patiente.

2

QUESTION

Citez les 5 caractéristiques principales du syndrome confusionnel.

3

QUESTION

Citez 5 causes possibles de l'insuffisance rénale chez cette patiente ?

Réponses proposées :

Tournez S.V.P. (Partie 4 : RHUMATOLOGIE Une patiente âgée de 55 ans consulte pour des lombalgies évoluant depuis 9 semaines. Il existe un syndrome rachidien à l'examen clinique.

1

QUESTION

Citez les 5 principaux diagnostics que vous devez évoquer.

2

QUESTION

Citez les 3 signes cliniques qui imposent une prise en charge en urgence.

QUESTION

3

En dehors de l'urgence, citez les 4 examens paracliniques contribuant au diagnostic étiologique. **Partie 5 : INFECTIOLOGIE** Vous accueillez un patient âgé de 42 ans, se plaignant d'une toux traînante dans un contexte d'asthénie et d'amaigrissement. Il est fébrile depuis 3 semaines environ. Ce patient originaire d'Ukraine vit en France depuis 3 ans avec sa famille dans des conditions précaires. Sa radiographie du thorax retrouve un infiltrat du lobe supérieur gauche.

QUESTION

1

Quel est le diagnostic le plus probable (1 seul diagnostic).

QUESTION

2

Quelles mesures immédiates mettez-vous en œuvre dans la prise en charge de ce patient : Quelles sont les techniques microbiologiques permettant d'établir le diagnostic ?

QUESTION

4

Quelle maladie associée devez-vous rechercher et quel examen supplémentaire demandez-vous (1 seul) ?

Réponses proposées :

Tournez S.V.P. (Partie 6 : DIGESTIF) Un homme de 50 ans, travaillant dans le bâtiment, se présente avec des douleurs abdominales aiguës épigastriques transfixiantes. Il est amené aux urgences par le SMUR. L'inspection montre un patient allongé, pâle, parlant difficilement. Le patient est fumeur chronique (25 paquets/année) et déclare avoir majoré récemment sa consommation d'alcool en raison de soucis familiaux et professionnels. Il n'a pas d'antécédent particulier en dehors de céphalées assez fréquentes.

QUESTION

1

Quelles sont les 4 principales causes de la douleur que vous devez évoquer en urgence chez ce patient ?

QUESTION

2

Enumérer les signes habituels d'un état de choc.

3

QUESTION

une irritation péritonéale. FILENAME \p G:\Pae\2012\Spec.71\EVCf.71
B.DOC Page Numpages ~vk`kUG hRgà hsiF h!sQ h6uñ h- 9 gdRgà gdKQ
gd6uñ gdHCê ippÖ øxlc hHCê hFW' hÑKg hyNU hh.Ú gdiW gdèlĭ gdP4 haLÉ
gdβU gda6t gdÉ3x gdò~ xrxr hÉ3x ~sØÂ ha6t hèĭ ~u~dVK@ }uquhuq^
hβyÂ gdTe8 Cp!v UÔhdP 7Êmf Lÿ^J òùOh ODONTOLOGIE Xêi@ Prodiser
Titre Document Microsoft Word MSWordDoc Word.Document.8

